EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91021
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-20 17:18:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LORENA CAROLINA ARIAS FUENTES			RUN	: 16.535.124-K
F.Nac	: 16-08-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-17	Fecha Egreso	: 2024-08-20 17:18:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

INFECCION VIAS URINARIAS BAJAS
LITIASIS URETERAL IZQUIERDA ELIMINADA
ANTECEDENTES: ASMA, HTA, OBESIDAD

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N20-N23-LITIASIS URINARIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE C/ANTEC DE HTA, ASMA LEVE S/TTO, OBESIDAD, CONSULTA EL DIA MARTES 13/08724, POR DOLOR ABDOMINAL EN REGION HIPOCONDRIO IZQUIERDO, SE TRATA SINTOMAS EN EL SERVICIO DE URGENCIA, CONSULTA POR SEGUNDA OPORTUNIDAD POR DOLOR ABDOMINAL MAS INTENSO LOCALIZADO EN HIPOCONDRIO IZQUIERDO, IRRADIADO A FLANCO Y FOSA LUMBAR IZQUIERDA, ASOCIADO A NAUSEAS, SE REALIZAN EXAMENES DE LAB. Y PRESENTA PCR 178, LEUCOCITOS 16500, ORINA INFLAMATORIO, SE REALIZA PIELOTAC Y PRESENTA EN URETER DISTAL IZQUIERDO PREVIO A UNION URETEROVESICAL SE OBJETIVA LITIASIS DE 2,7 MM DENSIDAD 916UH ASOCIADO A LEVE HIDROURETERONEFROSIS. SE REALIZA UN UROTAC POR PERSISTENCIA DE DOLOR Y PRESENTA EXAMEN SIN HALLAZGOS DE SIGNIFICADO PATOLOGICO ESPECIFICO, QUISTES PARAPIELICOS IZQUIERDOS, LESIONES ANEXIALES DE HASTA 38 MM. PACIENTE MUY QUEJUMBROSA Y POR PERSISTENCIA DE DOLOR SE DECIDE HOSPITALIZAR.
AL INGRESO PACIENTE CON MENOS DOLOR, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, AFEBRIL

SE RESCATÓ UCT QUE REPORTA POLIMICROBIANO: NECESARIO REPETIR
CON LESIONES ANEXIALES EN UROTAC: NECESARIO VALORACIÓN POR GINECOLOGÍA. SE REAÑIZA HOY Y DESCARTA LESIONES ANEXIALES SEÑALADAS EN TAC (CON ECO GINECOLOGICA)

PACIENTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE, COMPLETA 5 DIAS TTO ATB (CEFTRIAXONA) CON PARAMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA, ASINTOMATICA, ORINANDO OK, SE ASUME ELIMINO LITIASIS (PEQUEÑA) YA QUE NO APARECE EN CONTROL DE UROTAC.
POR LO ANTERIOR SE DECIDE HODOM PARA COMPLETAR TTO ATB POR ITU Y RESCATAR UC EN PROX DIAS

PLAN DE MANEJO:

A HODOM PARA COMPLETAR TTO ATB POR ITU. AL ALTA CONTROL EN APS SOS

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO: RELATIVO
2. RÉGIMEN: LIVIANO HIPOSODICO, LIQUIDOS ABUNDANTES
3. CEFTRIAXONA 2 GR EV X DIA POR 2 DIAS MAS (7 DIAS TOTAL)
4. PARACETAMOL 500 MG 2 COMPRIMIDOS C/8 HORAS VIA ORAL SOS
5. TRATAMIENTOS CRONICOS HABITUALES RETOMAR
6. RESCATAR UROCULTIVO PARA CONFIRMAR EFECTIVIDAD DE TTO ATB (Y POSIBLE AJUSTE)
7. CONTROLES CRONICOS POR APS
8. CONTROL SOS VIA URGENCIAS

EXÁMENES Y RESULTADOS

15/08 PieloTC:
Urterolitiasis distal izquierda (2.7mm) con leve HUN. Discreto liquido en excavación pelviana.

16/08 UROTC
Examen sin hallazgos de significado patológico específico respecto del diagnóstico clínico de referencia. Quistes parapiélicos izquierdos.
Lesiones anexiales bilaterales 38mm Derrame pleural izquierdo leve, con atelectasia parcial basal ipsilateral secundaria.

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO